Établissement

Médecin responsable

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS D'URGENCE — ARTICLE R.4311-7 CSP

Dépression respiratoire aux opioïdes – Naloxone

Adulte sous opioïde · enfant : 15 et PAI (naloxone injectable au poids)

URGENCE VITALE → 15 IMMÉDIAT · ne répond pas, ne respire pas ou respire anormalement (pauses, ronflement), cyanose, SpO2 < 90 % ; arrêt : RCP + DSA d'abord.

J'applique si

- Sous **opioïde** (morphine, oxycodone, fentanyl patch, tramadol, codéine…) ou surdosage suspecté.
- **Sédation S2–S3 et FR < 10/min** (comptée sur 1 min) ; pauses, ronflement, myosis serré, SpO2 < 90 %.
- Sédation : S1 somnolent par moments · **S2 éveillable à la voix** · **S3 au toucher seulement**.

Je n'applique pas → avis médical

- S0–S1 avec FR ≥ 10/min : **pas de naloxone**, surveiller.
- S2 avec FR ≥ 10/min : pas de naloxone ; suspendre l'opioïde, avis **dans l'heure**.
- Enfant : sprays et Prenoxad non indiqués ; naloxone injectable selon PAI ou 15.

J'agis

ACTES CONSERVATOIRES (R4311-7)

1. **Stimuler**, libérer les voies aériennes ; **15** en parallèle.
2. **Arrêter l'opioïde** : pompe stoppée, **patch retiré**, heure notée.
3. **O2** pour SpO2 ≥ 90 % ; respiration insuffisante : **BAVU + O2** si formé.

SUR CE PROTOCOLE D'URGENCE

4. **Naloxone** (carte ci-contre) jusqu'à **FR ≥ 10** et éveil à la voix.
5. Palliatif : viser FR ≥ 10 et éveil, pas la levée de l'antalgie ; titrer au plus juste.

SUR ORDRE DU 15

6. Doses suivantes, perfusion (LP, patch, méthadone), transfert.

Consigne orale du 15 ou du médecin → télé-prescription écrite, annexée au dossier.

Naloxone

IV : titration

1 amp. **0,4 mg** + 9 mL NaCl = **0,04 mg/mL**

2 mL, puis **1 mL / 3 min**

Sans voie IV

0,4 mg IM ou SC (1 ampoule pure)

- Effet en ≈ 10 min, durée 2–3 h
- Prenoxad IM (adulte) : 0,4 mL toutes les 2–3 min, 5 doses au plus
- Spray adulte : Nyxoid 1,8 mg (≥ 14 ans) ou Ventizolve 1,26 mg ; 2e dose à 2–3 min, autre narine

J'appelle le médecin

- S2 avec FR ≥ 10 : opioïde suspendu, avis **dans l'heure**.
- Douleur ou sevrage après naloxone : réadapter l'antalgie (pas d'opioïde sans prescription).

Je surveille et je trace

- Sédation, FR, SpO2 **toutes les 10–15 min** : **re-sédation** possible (LP, patch ; naloxone IV : 20–30 min).
- Sevrage (agitation, sueurs, vomissements), douleur ; doses (heure, voie, lot), réponse.
- **Compte rendu écrit, daté, signé**, remis au médecin (R4311-7).

À retenir : Ventiler d'abord, antagoniser ensuite, et titrer. Réveillé par la naloxone ne veut pas dire hors de danger.

Fait à : .....

Le : ..... / ..... / .....

Signature et cachet du médecin :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : Art. R4311-7 CSP ; RCP Narcan 0,4 mg/1 mL et Naloxone Aguettant 0,4 mg/mL (ANSM, MAJ 29/09/2026), Prenoxad 0,91 mg/mL (MAJ 29/09/2026), Ventizolve 1,26 mg (MAJ 29/09/2026) ; EMA, RCP Nyxoid 1,8 mg ; OMéDIT Centre-Val de Loire, protocole infirmier naloxone (2017, annexe du guide Urgences en EHPAD 02/2025) ; Fiche 0 ARS IDF 2016.

Réf. DOTR-IDE-NALOX | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature